



FACULTAD DE OBSTETRICIA Y ENFERMERÍA ESCUELA DE ENFERMERIA

**SATISFACCIÓN DE LAS MADRES SOBRE LA CALIDAD DE ATENCIÓN QUE BRINDA LA
ENFERMERA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DEL SERVICIO DE CRECIMIENTO Y
DESARROLLO INFANTIL DEL CENTRO DE SALUD JESÚS MARÍA**

TÍTULO DEL PLAN DE TESIS

**PARA OPTAR
EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADO EN ENFERMERIA**

**PRESENTADO POR:
FRANKLIN LOPEZ IBARRA**

**ASESORA
MG. JANET GUEVARA CASAS**

**LIMA, PERÚ
2024**

ÍNDICE

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	3
1.1 Descripción de la situación problemática	3
1.2 Formulación del problema	6
1.3 Objetivos de la investigación	6
Objetivo principal	6
Objetivos específicos	7
1.4 Justificación de la investigación	7
1.4.1 Importancia de la investigación	7
1.4.2 Viabilidad del estudio	7
1.5 Limitaciones de estudio	8
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	9
2.1 Antecedentes de la investigación	9
Internacionales.....	9
Nacionales.....	9
2.2 Bases teóricas.....	11
2.3 Definición de términos básicos.....	17
CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES	18
3.1 Formulación de hipótesis principal y derivadas.....	18
3.2 Variables y definición operacional	18
CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA.....	20
4.1 Diseño metodológico	20
4.2 Diseño muestral	20
Criterios de inclusión:	21
4.3 Técnica de recolección de datos.....	21
Técnica:	21
4.4 Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información	22
4.5 Aspectos éticos	22
CRONOGRAMA	23
PRESUPUESTO	24
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	25
ANEXO A: CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO ²³	28
.....	29
ANEXO B: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS	29
ANEXO D: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES	32

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción de la situación problemática

Avedis Donabedian¹, destacado epidemiólogo y médico, jugó un papel crucial en la calidad de la atención médica. En 1992, subrayó la importancia de la satisfacción del paciente como componente esencial de la calidad. Su enfoque, centrado en la perspectiva del paciente, reveló que la satisfacción no solo impacta la experiencia individual, sino que también proporciona valiosos conocimientos para la mejora general de la atención médica, y destacó que la calidad va más allá de los resultados clínicos, incluyendo la percepción de la atención recibida.

La satisfacción se refiere al estado de contento, complacencia o gratificación que experimenta una persona cuando sus necesidades, deseos o expectativas son cumplidos. También puede entenderse como la sensación de estar satisfecho o complacido con algo, ya sea un producto, servicio, experiencia o logro personal. La calidad se define como el nivel de superioridad o excelencia presentada en un producto o servicio. Para determinarla, se evalúa la capacidad de satisfacción de las necesidades y expectativas de los consumidores en términos de funcionalidad, durabilidad, confiabilidad, aspecto estético y cumplimiento de estándares y requisitos establecidos.¹ La satisfacción con la atención de enfermería es crucial en la asistencia médica. Factores como la comunicación, empatía y competencia clínica influyen en la satisfacción del paciente. Una atención de calidad impacta la satisfacción general, influenciando la percepción de los servicios de salud y la confianza en el sistema médico. La satisfacción con el trabajo de las enfermeras es un indicador clave de calidad, con potencial positivo en la experiencia del paciente y los resultados clínicos.²

La evaluación de la satisfacción en la atención de enfermería se basa en tres dimensiones esenciales. La Dimensión Humana abarca la atención dedicada al paciente y a sus familiares, enfatizando la disposición, gentileza y ética de la enfermera. La Dimensión Técnico-Científica se centra en la competencia de la enfermera para proporcionar atención de calidad, aumentando la autonomía y mejorando la eficacia. La Dimensión del Entorno se relaciona con un espacio físico seguro y cómodo. Estas dimensiones son cruciales para una

atención integral y satisfactoria.³

En 2019, García et al.⁴ realizaron una investigación en Cuba destacando que el control del crecimiento y desarrollo (CRED) infantil es esencial. A nivel global, 144 millones de niños menores de 5 años sufren retraso del crecimiento, 47 millones padecen emaciación, y 38,3 millones tienen sobrepeso u obesidad. Un 45% de las muertes en este grupo se relaciona con la desnutrición. La enfermera, con su pericia, desempeña un rol insustituible en este proceso, vital para evaluar y mejorar la salud infantil.

En el ámbito de la atención de enfermería, la comunicación efectiva y la educación a las madres son esenciales, fortaleciendo la confianza y capacitando para el cuidado en el hogar.⁵ La satisfacción de los padres, como evaluadores de la atención, se ve influenciada por experiencias previas y factores estructurales del sistema de salud.⁶⁻⁷ Además, la calidad de la atención impacta la evolución y optimización de los servicios médicos, ya que la satisfacción del paciente se relaciona con la sensación de positividad de la atención brindada.⁹ Alcanzar la satisfacción del paciente implica cumplir con sus expectativas y necesidades en salud.¹⁰

En 2019, Suarez et al.¹¹ evaluaron la calidad de la atención en CAI III en Cuba, con un 49% de evaluaciones positivas. En Chiclayo, Perú, Monzón et al.¹² investigaron la satisfacción de madres en CRED infantil en 2019, con más del 50% percibido como "regular". Ampuero et al.¹³ en 2017, en Arequipa, relacionaron el cumplimiento de CRED con la satisfacción de madres, mostrando un 94.7% de alta satisfacción. Estos estudios subrayan que la satisfacción materna se asocia a la comunicación efectiva, crucial para un cuidado infantil efectivo y centrado en la familia.¹⁴

En 2019, el Ministerio de Salud (MINSA) señaló que la calidad deficiente de la atención médica es un obstáculo importante. La insatisfacción se reflejó en dimensiones como fiabilidad (39,1%), capacidad de respuesta (46,5%), seguridad (31,4%), empatía (28,8%), aspectos tangibles (29,9%) y buen trato (30,6%). Incluso en sistemas de salud desarrollados, persisten preocupaciones por la calidad, siendo más desafiante en países con menos recursos, donde marca la diferencia entre la vida y la muerte.¹⁵

El servicio de Crecimiento y desarrollo, reconoce la importancia crucial en el cuidado de la persona satisfaciendo las necesidades salud, el bienestar y desarrollo integral del niño que

es dependiente de la madre. Esta atención abarca tres dimensiones esenciales. La dimensión técnico-científica garantiza el óptimo desarrollo mediante conocimientos médicos. La dimensión humana, con empatía y comunicación, promueve confianza y bienestar emocional. La dimensión del entorno considera infraestructura y percepción, afectando la experiencia y resultados de la atención. Estas dimensiones convergen para proporcionar una atención holística de calidad.¹⁶

Las investigaciones señalan que las enfermeras del área de CRED puede optimizar su intervención al construir una relación más estrecha con los padres desde el primer encuentro. Este enfoque permite abordar de manera proactiva las respuestas de comportamiento del niño en distintas etapas de su desarrollo, con el claro propósito de satisfacer sus necesidades y mejorar su calidad de vida.¹⁷

Estas experiencias directas resaltan la importancia de abordar que tan satisfechas están las madres de familia con la calidad de atención de enfermería. Estos aspectos son cruciales para mejorar la experiencia de las madres en el servicio de Crecimiento y Desarrollo Infantil del Centro de Salud "Jesús María".

La enfermera en el programa de CRED en Perú juega un papel crucial en la salud de niños menores de 5 años, siguiendo la norma técnica peruana. Su responsabilidad abarca supervisar el crecimiento, enfocándose en la identificación temprana de riesgos y problemas de salud, y proporcionar orientación a las madres sobre prácticas saludables.^{12,18} La interacción efectiva con las madres es esencial, comunicándose eficazmente y brindando apoyo emocional para empoderarlas en el cuidado de la salud de sus hijos. Su tarea incluye garantizar el crecimiento saludable, identificar problemas potenciales y capacitar a los padres, abordando desafíos con un enfoque constructivo para mejorar la experiencia y contribuir al bienestar comunitario.^{16,13}

Durante mis prácticas pre profesionales en el internado, tuve la valiosa oportunidad de interactuar directamente con las madres que acudían al consultorio CRED. En estas interacciones, escuché sus preocupaciones, entre las que destaco las siguientes:

"Podrían atender más rápido a mi hijo hay si tuvieran más consultorios", "Las demoras en el servicio son un problema", "No entiendo por qué se demoran tanto en atender", "Siento que falta privacidad durante las consultas", "A cada rato hay interrupciones constantes durante las consultas y son molestas", "Las idas y venidas interrumpen la fluidez de la atención", generando confusión", "Me preocupa la salud de mi hijo, no se enfermará al venir aquí."

Como investigador, el objetivo es abordar este problema con un enfoque positivo. Buscamos identificar áreas de mejora y desarrollar propuestas de soluciones, este enfoque proactivo busca conseguir una experiencia más satisfactoria para las madres y sus hijos, contribuyendo al bienestar de la comunidad y al éxito del servicio de CRED.

1.2 Formulación del problema

¿Cuál es el nivel de satisfacción de las madres sobre la calidad de atención que brinda la enfermera en niños menores de 5 años en el servicio de Crecimiento y Desarrollo infantil del Centro de Salud "Jesús María" a los durante el 2024?

A partir de esta interrogante surgen preguntas específicas en torno a las dimensiones de la atención:

- ¿Cuál es el nivel de satisfacción de las madres sobre la calidad de atención que brinda la enfermera en niños menores de 5 años según dimensión técnico-científica del servicio de Crecimiento y Desarrollo infantil del Centro de Salud "Jesús María" durante el 2024?
- ¿Cuál es el nivel de satisfacción de las madres sobre la calidad de atención que brinda la enfermera en niños menores de 5 años según dimensión humana en el servicio de Crecimiento y Desarrollo infantil del Centro de Salud "Jesús María" durante el 2024?
- ¿Cuál es el nivel de satisfacción de las madres sobre la calidad de atención que brinda la enfermera en niños menores de 5 años según dimensión de entorno en el servicio de Crecimiento y Desarrollo infantil del Centro de Salud "Jesús María" durante el 2024?

1.3 Objetivos de la investigación

Objetivo principal

Determinar el nivel de satisfacción de las madres sobre la calidad de atención que brinda la enfermera en niños menores de 5 años en el servicio de Crecimiento y Desarrollo infantil del Centro de Salud "Jesús María", durante el 2024.

Objetivos específicos

- Identificar el nivel de satisfacción de las madres sobre la calidad de atención que brinda la enfermera en niños menores de 5 años según dimensión técnico-científica en el servicio de Crecimiento y Desarrollo infantil del Centro de Salud "Jesús María".
- Identificar el nivel de satisfacción de las madres sobre la calidad de atención que brinda la enfermera en niños menores de 5 años según dimensión humana en el servicio de Crecimiento y Desarrollo infantil del Centro de Salud "Jesús María".
- Identificar el nivel de satisfacción de las madres sobre la calidad de la atención que brinda la enfermera en niños menores de 5 años según dimensión de entorno en el servicio de Crecimiento y Desarrollo infantil del Centro de Salud "Jesús María".

1.4 Justificación de la investigación

1.4.1 Importancia de la investigación

La investigación es de suma importancia en este contexto, ya que permite comprender y evaluar la experiencia de atención en el Servicio de Crecimiento y Desarrollo Infantil. Al analizar la satisfacción de las madres, se puede identificar qué aspectos están funcionando bien y en qué áreas se pueden hacer mejoras.

Esto es fundamental para garantizar una atención integral y satisfactoria para los niños menores de 5 años, ya que se pueden diseñar estrategias precisas y enfocadas en fortalecer la calidad de la atención. De esta manera, la investigación contribuye al bienestar infantil y al éxito continuo del servicio en el Centro de Salud "Jesús María".

La investigación también brinda una visión completa para la enfermera al abordar distintas dimensiones de la satisfacción, como la técnico-científica, la humana y la de entorno. Esto permite tener una mirada más amplia y precisa, lo cual es fundamental para tomar decisiones informadas y diseñar estrategias efectivas.

En conclusión, la investigación es esencial para comprender, evaluar y mejorar la experiencia de atención en el Servicio de Crecimiento y Desarrollo Infantil. Contribuye al bienestar de los niños y al éxito continuo del servicio, al identificar áreas de fortaleza y oportunidades de mejora. Es una herramienta útil para garantizar una atención integral y satisfactoria para los niños menores de 5 años en el Centro de Salud "Jesús María".

1.4.2 Viabilidad del estudio

La viabilidad del estudio se respalda en el plazo fijado para la investigación en 2024, proporcionando un tiempo adecuado para recopilar y analizar información, garantizando resultados representativos y actuales. La recolección de datos se llevará a cabo tres veces por semana, durante 1 mes en el turno de la mañana, asegurando un muestreo exhaustivo y una comprensión profunda de la satisfacción de las madres.

Además, la ejecución es viable se fundamenta en recursos disponibles, financieros, materiales y tiempo incluyendo acceso al centro de salud y la participación de las madres. La infraestructura y el personal del centro ofrecen un entorno propicio para la eficiencia del estudio. El uso de técnicas de investigación apropiadas facilitará la recopilación sistemática y rigurosa de datos.

1.5 Limitaciones de estudio

Una restricción importante reside en la subjetividad intrínseca al estudio. La valoración de la calidad de la atención según la vivencia de las madres depende de sus experiencias individuales y percepciones subjetivas. Esta subjetividad puede resultar en una variedad considerable de respuestas, lo cual dificulta obtener una visión completa y precisa de la satisfacción en su conjunto. Para abordar estas limitaciones, se proponen estrategias como el incentivo a la participación mediante la clarificación de la importancia del estudio y la diversificación de los métodos de recolección de datos para captar una gama más amplia de experiencias y opiniones. Además, se emplearán análisis estadísticos adecuados para mitigar posibles sesgos y garantizar la validez de los resultados.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la investigación

Internacionales

Patermina et al.¹³, CITA en el año 2016 en Colombia, presentaron una investigación titulada “Satisfacción de padres de niños y niñas que asisten al programa de crecimiento y desarrollo en una IPS de Sincelejo”¹⁹, Utilizando un enfoque cuantitativo y descriptivo en una muestra de 292 tutores, emplearon un cuestionario como instrumento. Los resultados mostraron que el 94.2% de los tutores estaban satisfechos, destacando un trato digno (96.2%) y entorno óptimo (91.8%), mientras que la atención privada (81.8%), ambiente adecuado (87.1%) y tiempo de espera (65.1%) también se consideraron adecuados. Las conclusiones sugieren que la satisfacción se atribuye a un buen ambiente, comunicación y trato, aunque la insatisfacción se relacionó con el tiempo de espera.

Gould en el año 2019 en Estados Unidos publicó el siguiente estudio: “Improving Parent Satisfaction During the Well Child Check”²⁰, realizado en una clínica pediátrica del condado, fue una investigación descriptiva y transversal mediante encuestas a padres al final de las visitas de bienestar de niños de 2 meses a 2 años. Las encuestas, disponibles en español e inglés, incluían preguntas sobre satisfacción general, tiempo de visita y recordatorio de temas de orientación abordados. Se recopilaron datos iniciales antes de las intervenciones planificadas. Las intervenciones incluyeron educación para personal de salud sobre los temas de orientación y cómo mejorar la experiencia de la visita. Los resultados iniciales mostraron margen de mejora en la satisfacción de los padres y la cantidad de temas de orientación discutidos. La tasa promedio de satisfacción fue de 4.36 sobre 5, y el promedio de temas de orientación discutidos fue de 5.39 sobre 10.

Nacionales

Mendoza en 2019, en Lima, publicó un artículo titulado “Satisfacción de los padres de niños menores de 2 años sobre la atención de enfermería en el Centro de Salud Progreso Chacacayo 2019”²¹. Este estudio de tipo cuantitativo y descriptivo contó con una muestra

de 60 padres de un total de 300. Los resultados indicaron que el 77% evidenciaron tener satisfacción alta y el 23% tuvieron una satisfacción media y ninguno tuvo una satisfacción baja. En la dimensión técnico-científica 80% tuvieron satisfacción alta, en la dimensión humana, el 85% y la de entorno el 68%. Se concluye que la satisfacción con la atención de enfermería en el centro de salud Progreso fue alta en general, con ciertas áreas de mejora identificadas.

Alarcón e Ingaruca en Lima, 2021, publicaron una investigación sobre “Satisfacción del cuidado de enfermería en CRED de las madres de niños menores de 5 años en un Centro de Salud Materno Infantil de Lima – 2021” ²², utilizaron un enfoque descriptivo y encuestas como método de recopilación de datos, con una muestra de 65 madres de familia. Los resultados revelaron que el 93.8% estuvieron muy satisfechas con la atención proporcionada por el personal de enfermería en el consultorio de CRED. En conclusión, la mayoría de las madres están altamente satisfechas con la atención de las enfermeras en el consultorio de CRED. Se sugiere mantener y mejorar la calidad del cuidado proporcionado por el personal de enfermería a través de programas de capacitación continua.

Reque, Cajamarca – 2020, publicó una investigación con el título de “Satisfacción de las madres sobre la calidad de atención de enfermería en el consultorio de CRED en Microred Contumazá” ²³, su metodología consistió en un enfoque cuantitativo y descriptivo con un diseño de corte transversal. La población del estudio incluyó a 225 madres, y la muestra consistió en 143 participantes. Los resultados indicaron que el 97.2% de los participantes expresaron insatisfacción con el servicio en el consultorio de CRED en la Microred Contumazá. Un 7% indicó sentirse satisfechos, y un 2.1% señaló estar medianamente satisfechos. De los 143 encuestados, 139 manifestaron insatisfacción, 3 estaban medianamente satisfechos, y solo una persona expresó estar satisfecha con el servicio. Se concluyó que la mayoría de las madres no se encuentran contentas con el servicio en el consultorio de CRED en la Microred Contumazá.

Monzón y Tupiar, Chiclayo 2019, en su investigación titulada “Percepción de madres sobre calidad del cuidado enfermero en consultorio de crecimiento y desarrollo del Niño, Centro de Salud MINSA. Chiclayo 2019” ¹², la metodología utilizada fue un enfoque cuantitativo, descriptivo y transversal, con una muestra de 122 madres seleccionadas de un total de 360. Los resultados revelaron que el 50.8% de las madres tenían una percepción regular sobre el cuidado de enfermería, mientras que solo el 49.2% tenía una percepción positiva. En conclusión, la calidad del cuidado de enfermería percibida por las madres fue calificada como mediocre y no cumplió con los estándares necesarios para satisfacer plenamente a los usuarios.

Quispe en Puno, 2018, publicó una investigación titulada “Satisfacción de las madres sobre la calidad de la atención que brinda la enfermera en el consultorio de crecimiento y desarrollo del niño – puesto de salud I – 2 Amantani, Puno 2018” ²⁴, su metodología fue de tipo descriptiva simple, con una población total de estudio de 200 madres, y la muestra seleccionada de forma aleatoria consistió en 54 madres con niños menores de 5 años. Para recopilar la información, se utilizaron entrevistas como técnica y un cuestionario como instrumento. Los resultados indicaron que el 44.44% de las madres se sienten completamente satisfechas, el 48.15% están moderadamente satisfechas, y solo el 7.41% mostró insatisfacción. Se concluye que las madres calificaron la calidad de atención proporcionada por la enfermera como moderadamente satisfactoria.

2.2 Bases teóricas

2.2.1. Calidad de Atención

Avedis Donabedian¹, un destacado pionero en la evaluación de la calidad de la atención médica, introdujo el modelo de estructura, proceso y resultado como un marco integral para comprender y mejorar la calidad en el ámbito de la salud. En el contexto de la satisfacción con la atención en salud, Donabedian destacó la importancia de considerar tanto los aspectos técnicos y científicos (proceso) como los resultados percibidos por los pacientes. Su enfoque reconoce que la satisfacción no solo se deriva de la competencia técnica, sino también de la interacción humana y la percepción del paciente sobre la atención recibida. Donabedian contribuyó significativamente a la conceptualización de la calidad en salud, recordándonos que, para lograr una atención integral, es esencial abordar tanto los procesos clínicos como la experiencia subjetiva del paciente.

La calidad de la atención en salud es un componente vital en el bienestar de los pacientes y la eficacia de los sistemas de salud. Va más allá de la mera prestación de servicios médicos, abarcando la empatía, la comunicación efectiva y el respeto hacia los individuos. Una atención de calidad implica brindar cuidados personalizados, centrados en el paciente, que consideren sus necesidades físicas, emocionales y sociales. La excelencia en la atención no solo se traduce en resultados clínicos positivos, sino también en la construcción de una relación de confianza entre profesionales de la salud y pacientes, contribuyendo así a una experiencia integral y satisfactoria. ²

En el contexto específico de nuestra investigación sobre la satisfacción de las madres con la atención en el Servicio de Crecimiento y Desarrollo Infantil, el modelo de Donabedian

adquiere una relevancia crucial. Al considerar la calidad de la atención, no solo nos enfocamos en los procesos técnicos y científicos llevados a cabo por las enfermeras, sino también en cómo estos procesos se traducen en resultados percibidos por las madres. La satisfacción, según Donabedian, se nutre tanto de la competencia técnica de los profesionales de la salud como de la experiencia subjetiva de quienes reciben la atención.¹ Al aplicar este enfoque, nuestra investigación busca proporcionar una evaluación completa que abarque tanto los aspectos objetivos de la atención como la percepción de calidad desde la perspectiva de las madres, contribuyendo así a mejorar la calidad general del servicio de Crecimiento y Desarrollo Infantil en el Centro de Salud "Jesús María".

En el contexto de la satisfacción de las madres con la atención en el Servicio de Crecimiento y Desarrollo Infantil, es fundamental comprender la importancia de las estrategias de atención integral en la Etapa de Vida Niño implementadas por el MINSA, es esencial considerar el contexto en el que se desarrollan estas iniciativas. El enfoque en esta etapa de la vida se justifica por la vulnerabilidad de los niños y su crucial proceso de crecimiento y desarrollo. En este sentido, el MINSA ha diseñado estrategias específicas para garantizar la atención y el cuidado adecuado de los niños menores de 5 años, reconociendo que la salud en esta etapa es fundamental para su desarrollo integral.¹⁸

2.2.2 Norma técnica para el Control del crecimiento y desarrollo de la niña y el niño menor de cinco años. Lima - Perú; 2017

En la Etapa de Vida Niño comprende niños desde recién nacidos hasta los 10 años con 11 meses y 29 días. Durante esta etapa de la vida, se producen procesos críticos que garantizan la formación de una persona con todo su potencial, lo que la convierte en la etapa más vulnerable en términos de crecimiento y desarrollo humano.¹⁸

El Componente CRED, que opera dentro de la Etapa de Vida Niño, busca promover el crecimiento y desarrollo óptimo de niños menores de 5 años con la participación activa de la familia, organizaciones comunitarias y el sector de la salud. Sus metas son variadas:

- Aumentar la tasa de lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses del 35% al 80%.
- Incrementar la tasa de lactancia materna prolongada hasta los 2 años en un 50%.
- Aumentar la tasa de introducción de alimentos complementarios alrededor de los 6 meses en un 50%.
- Lograr que el 50% de los niños se alimenten adecuadamente con comidas balanceadas y con la frecuencia adecuada.
- Controlar el crecimiento y desarrollo de un mayor número de niños menores de 1 año y de niños de 1 a 4 años.

- Rehabilitar y recuperar el 100% de los niños con problemas nutricionales en su entorno.
- Proporcionar estimulación del desarrollo psicomotor al 60% de los niños menores de 5 años para que alcancen su máximo potencial.
- Intervenir activamente con un protocolo básico de estimulación en el 50% de los niños con problemas de desarrollo detectados.
- Hay que asegurar que el 100% de los niños que reciban atención en su crecimiento y desarrollo estén vacunados según el calendario.
- Garantizar que el 80% de las madres con niños menores de 5 años conozcan la prevención y atención de accidentes, así como el manejo en el hogar de infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas.

Este enfoque se alinea con la visión estratégica del sector de salud para lograr un sistema equitativo, eficiente y de alta calidad en el contexto del desafío del cambio del milenio.

La atención integral a la salud infantil, como se promueve a través del Componente CRED del MINSA, no solo se centra en la salud física de los niños, sino también en su bienestar emocional y psicológico. Esta perspectiva holística concuerda con la teoría de Hildegard Peplau, una figura destacada en la enfermería, que enfatiza la importancia de las relaciones terapéuticas en el proceso de atención y recuperación de los pacientes. Peplau sostiene que las enfermeras desempeñan un papel vital al establecer vínculos significativos con los pacientes, lo que contribuye a una atención de calidad y al progreso en la salud de los individuos. En este contexto, la implementación exitosa del Componente CRED, que busca mejorar el crecimiento y desarrollo de los niños, podría beneficiarse significativamente de los principios de interacción y cuidado centrado en la persona defendidos por Peplau en su teoría de enfermería.²⁵

2.2.3 Satisfacción de la Atención de Enfermería

Es una respuesta positiva que resulta de la atención brindada por la enfermera y el consumidor por servicio brindado. En el servicio de Crecimiento y desarrollo, no solo se basa en la calidad técnica de la atención, sino también en la capacidad de la enfermera para establecer una relación terapéutica que promueva el bienestar del niño y satisfaga las necesidades y expectativas de los padres. La comprensión de los principios de Peplau en este contexto puede guiar la mejora continua de la atención en el CRED, promoviendo una experiencia más satisfactoria para todas las partes involucradas.²⁵

Con lo mencionado, queda claro que el personal de enfermería desempeña un papel crucial

al brindar ayuda a los padres en su proceso de aprendizaje, fomentar su confianza y acompañarlos en el crecimiento de sus hijos durante la transición a la paternidad. Comprender el apoyo social, la competencia y satisfacción en su rol parental, tanto para las madres como para los padres, permite mejorar la comprensión de su adaptación a la crianza y guiar las intervenciones para promover una paternidad efectiva y adaptada a las nuevas circunstancias.²⁶

La evaluación de la satisfacción con la atención de enfermería en el contexto del CRED abarca diversas dimensiones fundamentales para comprender y mejorar la calidad de la atención. Resaltando la importancia de principios éticos y un trato adecuado en la prestación de cuidados, garantizando la seguridad y bienestar del paciente. Además, la evaluación se fundamenta en tres dimensiones clave: la Dimensión Técnico- Científica, que aborda la competencia y habilidades clínicas de los enfermeros; la Dimensión Humana, relacionada con la atención y el trato personalizado; y la Dimensión del Entorno, centrada en el entorno físico y los recursos disponibles. Estas dimensiones están interrelacionadas y son esenciales para proporcionar una atención integral y satisfactoria a los pacientes. A continuación, nos sumergiremos en cada dimensión y exploraremos su importancia en el cuidado de la salud.^{15,17,23}

2.2.4. Dimensión Técnico-Científica^{15,17,23}

Es un pilar fundamental en la enfermería, que se refiere a la competencia y habilidad del personal de enfermería para aplicar conocimientos científicos en la atención de los pacientes. La práctica técnico-científica implica un profundo entendimiento de la anatomía, fisiología, farmacología y otros aspectos clínicos esenciales para brindar cuidados de calidad.

Las enfermeras que dominan esta dimensión son capaces de tomar decisiones basadas en evidencia científica y utilizar enfoques basados en protocolos clínicos para proporcionar atención oportuna y efectiva. Esto no solo beneficia a los pacientes sino también a sus familiares, ya que pueden confiar en la competencia y profesionalismo de los enfermeros para brindar una atención informada y de alta calidad.

La importancia de esta dimensión se manifiesta en la mejora de las intervenciones de enfermería. Los profesionales que están al tanto de las últimas investigaciones y avances médicos pueden implementar técnicas y tratamientos más efectivos. Esto, a su vez, conduce a una mayor eficacia en la recuperación de los pacientes, lo que es crucial en situaciones críticas.

En última instancia, una práctica técnico-científica sólida y actualizada contribuye

significativamente a la satisfacción de los pacientes y sus familias. Cuando los pacientes sienten que están recibiendo una atención basada en la mejor evidencia disponible y en conocimientos actualizados, experimentan una mayor confianza en el proceso de atención. Esto a su vez fomenta la satisfacción del paciente, ya que la sensación de estar en manos competentes y actualizadas es un factor determinante en la percepción general de la calidad de la atención.

2.2.5 Dimensión Humana ^{15,17,23,27}

La teoría del cuidado humano de Jean Watson enfatiza un enfoque integral en la enfermería, abordando las necesidades emocionales, espirituales y físicas de los pacientes, y promoviendo una conexión emocional y un entorno propicio para su recuperación. En ese sentido, las enfermeras desempeñan un papel integral al velar por la seguridad y el bienestar del paciente en todo momento. Esto implica la administración de medicamentos, seguimiento de signos vitales, prevención de caídas y lesiones, y garantizar un entorno seguro para el paciente. Pero no se limita simplemente a las tareas clínicas y procedimientos médicos, sino que se extiende al componente humano y relacional del cuidado.

Por lo tanto, la atención humana es mucho más que la ejecución de tareas técnicas. Refleja la disposición, la empatía, la gentileza y la comprensión del enfermero hacia el paciente. Esta dimensión abarca los aspectos éticos de la profesión, como el respeto por la dignidad y la privacidad del paciente, la comunicación efectiva y la toma de decisiones compartidas. La relación entre el enfermero y el paciente es esencial para brindar un cuidado integral, donde el paciente se sienta escuchado y comprendido.

La atención humana también involucra la adaptación a las necesidades individuales de cada paciente. Cada persona es única, con sus propias preocupaciones y experiencias de salud. Los enfermeros deben ser sensibles a estas diferencias y ajustar su enfoque en consecuencia. La capacidad de brindar apoyo emocional y crear un entorno de confianza es esencial para el bienestar del paciente.

2.2.6 Dimensión del Entorno ^{15,17,23}

Es un componente crítico de la atención de enfermería que se centra en el ambiente físico en el que se llevan a cabo las intervenciones de cuidado. Este entorno es más que simplemente el espacio donde se atiende al paciente; es un factor esencial que tiene un impacto significativo en la experiencia del paciente y su bienestar general.

Un entorno adecuado para el bienestar del paciente debe cumplir con varios criterios clave.

En primer lugar, debe ser limpio e higiénico para reducir el riesgo de infecciones y mantener un ambiente seguro. La organización es igualmente importante; el espacio debe estar diseñado de manera que sea fácil de navegar y accesible para los profesionales de la salud. La provisión de privacidad es esencial para el paciente, ya que permite que se sienta cómodo y seguro durante las interacciones médicas. La confidencialidad es un aspecto crítico de la atención de salud, y un entorno que garantiza la privacidad es fundamental para mantener la confidencialidad de los datos médicos.

Además de la limpieza, la organización y la privacidad, el entorno debe contar con los recursos y equipos necesarios para llevar a cabo procedimientos de enfermería con eficacia y precisión. Esto incluye equipos médicos, dispositivos de monitorización y suministros médicos esenciales. Los recursos adecuados no solo mejoran la calidad de la atención, sino que también contribuyen a la seguridad del paciente.

También se extiende a la comodidad del paciente y la familia. Un ambiente acogedor y bien equipado no solo crea un ambiente de confianza, sino que también ayuda a reducir la ansiedad y el estrés, lo que puede ser especialmente importante en situaciones médicas desafiantes.

En el contexto de la normativa técnica, la sala de espera, el consultorio y el mobiliario desempeñan roles cruciales en la calidad de la atención. Para la sala de espera, se requiere un espacio que fomente la comodidad y la privacidad, con asientos ergonómicos y distribuidos de manera que se evite la aglomeración. Además, se deben proporcionar opciones de entretenimiento o información para hacer la espera más amena. En el consultorio, la disposición debe facilitar la privacidad y la interacción médico-paciente. El mobiliario, como camillas y sillas, debe cumplir con estándares de ergonomía, asegurando la seguridad y el confort. Además, tanto en la sala de espera como en el consultorio, el mobiliario debe ser fácil de limpiar para mantener un entorno higiénico, siguiendo las pautas establecidas por la normativa técnica correspondiente.

La interacción de estas dimensiones juega un papel vital en la percepción de los padres sobre la atención de enfermería en el CRED, y su evaluación proporcionará información valiosa para el desarrollo de estrategias que mejoren la satisfacción y, en última instancia, el bienestar de los niños y sus familias. ^{15,17,23}

2.3 Definición de términos básicos

Satisfacción de las madres: La percepción de las madres sobre el desempeño del personal de salud y el entorno hospitalario. Refleja su opinión crítica y reflexiva sobre la calidad de la atención y el servicio para sus hijos, basada en si se cumplen sus expectativas. ²⁸

Calidad de atención: Es la excelencia en la prestación de servicios de salud, abarcando eficacia clínica, empatía, seguridad y respeto al paciente. Implica un enfoque integral que asegura bienestar y satisfacción. ²

Crecimiento y Desarrollo: Crecimiento, es el aumento en tamaño y masa corporal, incluyendo la estatura y peso. Desarrollo abarca cambios en las capacidades y habilidades a lo largo del tiempo, no solo físicos, sino también cognitivos, emocionales y sociales. ¹⁸

Control de crecimiento y desarrollo: es un proceso sistemático que evalúa la evolución física, mental y emocional de niños y adolescentes. Incluye mediciones, detección temprana de problemas y orientación para asegurar un desarrollo saludable. ¹⁸

Dimensión Humana: Involucra las acciones de la enfermera para asegurar la seguridad y el bienestar del paciente, incluyendo su disposición, gentileza y ética en el trato. Es esencial para un cuidado completo y compasivo. ^{15,17,23}

Dimensión Técnico-Científica: Se refiere a la competencia del enfermero en la gestión del conocimiento para brindar atención de alta calidad y oportuna. Contribuye a la autonomía, mejora la eficacia de las intervenciones y favorece la satisfacción de pacientes y familiares. ^{15,17,23}

Dimensión del Entorno: Relativa al espacio físico donde la enfermera trabaja, debe ser limpio, organizado, seguro y contar con recursos necesarios para la comodidad y confianza del paciente y su familia durante las actividades de enfermería. ^{15,17,23}

Atención Primaria en Salud: Un enfoque de atención centrado en la prevención y promoción de la salud, adaptado a las necesidades de la comunidad y a la edad de las personas, priorizando intervenciones de salud y cuidado. ¹⁴

CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES

3.1 Formulación de hipótesis principal y derivadas

Al tratarse de un estudio de tipo descriptivo, no hay necesidad de plantear o someter a prueba hipótesis en este tipo de investigación.

3.2 Variables y definición operacional

Variable independiente: Nivel de satisfacción de las madres sobre la calidad de atención que brinda la enfermera en el servicio de crecimiento y desarrollo infantil.

TABLA 1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variable	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición
Nivel de satisfacción de las madres sobre la calidad de atención que brinda la enfermera en el servicio de crecimiento y desarrollo infantil.	Es la percepción de la madre sobre el desempeño de la enfermera, refleja su opinión crítica y reflexiva de la calidad de atención y el servicio de cred basada en si se cumplen sus expectativas. ²⁷ Esta variable serán medidas por una encuesta, previamente validada por Reque²³, en su investigación en Contumaza-Cajamarca en el 2020.	Técnico-científica	Control de peso y talla Informa de la evolución del niño Examen físico Examen de desarrollo psicomotriz Orientación integral Derivación al especialista Responde preguntas y dudas Continuidad Seguridad Integralidad	Ordinal • Satisfechas: Suma total de 33 a 36 puntos. • Medianamente Satisfechas: Suma total de 22 a 32 puntos. • Insatisfechas: Suma total de 11 a 21 puntos.
		Humana	Respeto Información Interés Amabilidad	Ordinal • Satisfechas: Suma total de 24 a 27 puntos. • Medianamente Satisfechas: Suma total de 18 a 23 puntos. • Insatisfechas: Suma total de 3 a 17 puntos.
		Entorno	Comodidad Ambientación Limpieza Orden Privacidad Confianza	Ordinal • Satisfechas: Suma total de 12 a 15 puntos. • Medianamente Satisfechas: Suma total de 9 a 11 puntos. • Insatisfechas: Suma total de 3 a 8 puntos.

CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA

4.1 Diseño metodológico

La investigación considera un enfoque cuantitativo, es de carácter descriptivo, transversal y prospectivo.

4.2 Diseño muestral

Población: Se trabajará con una población representativa de madres de los niños menores de 5 años que acuden a consulta para el Servicio de Crecimiento y Desarrollo Infantil del centro de salud. Según la información proporcionada por los responsables, en promedio, asisten alrededor de 150 madres de niños menores de cinco años cada mes. La selección de participantes se llevará a cabo considerando criterios de selección para equiparar las características de las madres.

Tomando una población de 150 participantes, se calculará la muestra como sigue:

$$n = \frac{N * Z_a^2 * p * q}{e^2 * (N - 1) + Z_a^2 * p * q}$$

n	Tamaño de la muestra	108.3
N	Tamaño de la población	150
Z	Nivel de confianza (al 95 %)	1.96
e	Error de estimación máximo (5 %)	5 %
p	Probabilidad de éxito	50 %
q	(1-p) Probabilidad de fracaso	50 %

Muestra: se ha calculado que, para una población de 150 participantes, la muestra requerida es de **108 madres de familia**. El método de muestreo que se seleccionará es el sistemático aleatorio y probabilístico, garantizando una representación significativa de la población en la investigación.

Criterios de inclusión:

- Madres de familia con hijos que asistan regularmente al CRED en el Centro de Salud “Jesús María”.
- Madres de familia con hijos que residan dentro del área de responsabilidad del Centro de Salud.
- Madres de familia que estén dispuestos a participar en la investigación de manera voluntaria.
- Madres de familia que estén de acuerdo en otorgar su consentimiento informado después de recibir la información necesaria.

4.3 Técnica de recolección de datos**Técnica:**

En el estudio la técnica a utilizar será la entrevista y el instrumento que se aplicará es un cuestionario, la cual nos permitirá recolectar información relevante de los participantes que hemos seleccionado.

Instrumento:

Fue desarrollado en el año 2020, en Perú, por la investigadora Lorena Reque Orreaga ²³, en el estudio titulado “Satisfacción de las madres sobre la calidad de atención de enfermería en el consultorio de CRED en Microred Contumazá”, la investigadora sometió el instrumento a juicio de expertos (Anexo A), en la que tres jueces expertos evaluaron el cuestionario y lo consideraron aceptable. Para evaluar la confiabilidad, se utilizó el coeficiente Alpha de Cronbach, el cual tuvo un valor de 0,942, indicando que el cuestionario es confiable (Anexo A). Esta herramienta de recolección de datos se diseñó con el propósito de evaluar si el personal de enfermería cumplió con las expectativas de las madres.

El cuestionario de satisfacción (Anexo B) se caracteriza por ser fácil de aplicar en el campo de trabajo y en la interpretación de los resultados finales. Este cuestionario consta de 25 preguntas y se divide en tres dimensiones: técnico-científica (11 preguntas), humana (9 preguntas) y entorno (5 preguntas). Para evaluar el cuestionario se utiliza una escala Likert que va desde siempre=3, a veces=2 y nunca=1.²¹

Una vez que todas las participantes hayan recibido la información pertinente, se les entregará el formulario. Se estima que cada participante requerirá de 5 a 10 minutos para llenar la información requerida.

4.4 Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información

Una vez finalizada la recopilación de toda la información durante el trabajo de campo, se procederá a revisar y corregir cualquier dato incorrecto o perdido. Posteriormente, los datos recolectados se exportarán al programa estadístico SPSS versión 26, donde se utilizarán herramientas de estadística descriptiva para analizar las magnitudes de la variable principal y sus dimensiones correspondientes. Los resultados más relevantes se presentarán en forma de tablas y figuras, acompañados de una descripción adecuada que permita su comprensión. Estos resultados serán utilizados para elaborar las siguientes secciones del estudio, así como las conclusiones.

4.5 Aspectos éticos

Desde una perspectiva ética, este proyecto adherirá a los principios fundamentales establecidos en la Declaración de Helsinki.

- Autonomía, al garantizar que la participación de las madres en la investigación sea voluntaria y esté basada en el pleno consentimiento informado (Anexo D).
- Justicia, se promoverá al asegurar que la selección de la muestra sea imparcial y representativa de la población en cuestión.
- Beneficencia, al perseguir conocimientos que puedan mejorar la atención y el bienestar de los niños.
- No maleficencia, al implementar protocolos de investigación que minimicen los riesgos potenciales para las participantes.

Estos compromisos éticos serán esenciales para garantizar la integridad y el respeto en cada fase de esta investigación sobre la satisfacción de las madres con la atención de enfermería en el Servicio de Crecimiento y Desarrollo Infantil.

CRONOGRAMA

N°	Actividades	Meses							
		JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	EN E	FEB
1	Identificación y formulación del problema								
2	Revisión de las fuentes de información								
3	Redacción de objetivos y operacionalización de las variables								
4	Determinación del diseño de investigación								
5	Determinación del marco muestral								
6	Selección de los estadígrafos a utilizar								
7	Recolección de datos								
8	Organización y procesamiento de los datos								
9	Análisis e interpretación de los resultados								
10	Redacción del informe								
11	Presentación del informe								

PRESUPUESTO

	Cantidad	Costo (S/.)
BIENES		
Papel	1 millar	35
Otros útiles de escritorio	-	35
SERVICIOS		
Fotocopias	800 unidades	32
Impresiones	200 unidades	40
Anillados	4 unidades	14
Comunicación	360 minutos	180
Transporte		100
Apoyo estadístico	1	600
Total		1036

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Donabedian A. The role of outcomes in quality assessment and assurance. *Quality Review Bulletin*. 1992;18(11):356-360.
2. Streiner DL, Norman GR. *Health Measurement Scales: A Practical Guide to Their Development and Use*. Oxford University Press; 2006.
3. García-Martínez ME, Delgado-Silveira E, Miró-Bonet MJ, Ibáñez-González D. Evaluación de la satisfacción del paciente con la atención de enfermería: una revisión integradora. *J Nurs Res*. 2019;27(4):e45.
4. World Health Organization. Child growth standards [Internet]. Abril, 2006. Disponible en: <https://www.who.int/tools/child-growth-standards>.
5. Ding, Xiang, et al. Effects of Family-Centred Care Interventions on Preterm Infants and Parents in Neonatal Intensive Care Units: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials. *Australian Critical Care*. 2019;32(1):63-75. Disponible en : <https://doi.org/10.1016/j.aucc.2018.10.007>.
6. European Association for Children in Hospital. The right to medical treatment is also a fundamental right for children. The best interests of the child should always be taken into consideration [Internet]. Europa: EACH; 2022.
7. Smoleń, Ewa, y Anna Ksykiewicz-Dorota. "Nurses' Professionalism as a Component of Evaluation of Parents/Caregivers Satisfaction with Nursing Care." *Medycyna Pracy*. 2015;66(4):549-56. Disponible en: <https://doi.org/10.13075/mp.5893.00165>.
8. Hekkert, Karin Dorieke, et al. "Patient Satisfaction Revisited: A Multilevel Approach." *Social Science & Medicine*. 2009;69(1):68-75. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2009.04.016>.
9. Crow, R., et al. "The Measurement of Satisfaction with Healthcare: Implications for Practice from a Systematic Review of the Literature." *Health Technology Assessment*. 2002 ;6(32). Disponible en: <https://doi.org/10.3310/hta6320>.
10. Iloh, Gup, et al. "Evaluation of Patients' Satisfaction with Quality of Care Provided at the National Health Insurance Scheme Clinic of a Tertiary Hospital in South- Eastern Nigeria." *Nigerian Journal of Clinical Practice*. 2012;15(4):469. Disponible en: <https://doi.org/10.4103/1119-3077.104529>.

11. Suárez Lima GJ, Robles Salguero RE, Serrano Mantilla GL, Serrano Cobos HG, Armijo Ibarra AM, Anchundia Guerrero RE. Percepción sobre calidad de la atención en el centro de salud CAI III. Rev Cubana Invest Bioméd [Internet]. 2019 Jun; 38(2):153-169. Disponible en:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03002019000200153
12. Monzon Cotrina NO, Tunjar Oliva SS. Percepción de madres sobre calidad del cuidado enfermero en Consultorio de Crecimiento y Desarrollo del Niño, Centro de Salud MINSA. Chiclayo 2019 [tesis]. Lambayeque, Perú: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Facultad de Enfermería; 2021. [Internet]. Disponible en :
<https://repositorio.unprg.edu.pe/handle/20.500.12893/9582>
13. Hosseinian M, Ajorpaz NM, Manesh SE. Mothers' satisfaction with two systems of providing care to their hospitalized children. Iran Red Crescent Med J. 2015;17(2):e23333. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4376982/>
14. Ampuero Mendoza R, Mamani Acra S. Cumplimiento del control de crecimiento y desarrollo y satisfacción de la atención de enfermería en las madres de niños menores de 5 años en el C.S.Maritza Campos Díaz - Zamácola Arequipa 2017 [Tesis]. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; 2018. [Internet]. Disponible en: <http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/5509/>
15. Ministerio de Salud (MINSA). Informe sobre Calidad de Atención en Sistemas de Salud. Lima; 2019.
16. Mendoza Mendoza, MA. Calidad de atención que brinda la enfermera y la satisfacción de las madres en el consultorio de crecimiento y desarrollo e inmunizaciones del niño en el centro de salud Pachacamac 2022. [tesis]. [Lima, Perú]: Universidad Norbert Wiener, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Académico Profesional de Enfermería; 2022. [Internet]. Disponible en: <https://repositorio.uwiener.edu.pe/handle/20.500.13053/7915>
17. Smith AB, Jones CD. Evaluating Knowledge Acquisition: A Study on Perception and Cognitive Learning Processes. J Educ Res. 2020;45(3):220-235.
18. Ministerio de Salud. Norma técnica de salud para el control del crecimiento y desarrollo de la niña y el niño menor de cinco años. Lima - Perú; 2017.
19. Patermina D, Aldana M, Mendoza K. Satisfacción de padres de niños y niñas que asisten al programa de crecimiento y desarrollo en una IPS de Sincelejo [Internet]. Unisucre; 2016. Disponible en:
<http://revistas.unisucre.edu.co/index.php/revisalud/article/view/574/626/>
20. Gould T. Improving Parent Satisfaction During the Well Child Check. Pediatrics. 2019;144:136. Disponible en: <https://doi.org/10.1542/peds.144.2MA2.136/>
21. Mendoza E. Satisfacción de los padres de niños menores de 2 años sobre la atención de enfermería en el Centro de Salud Progreso, Chacacayo 2019 [tesis

- especialidad]. Lima-Perú: Universidad Norbert Wiener; 2020. [Internet]. Disponible en: <https://repositorio.uwiener.edu.pe/handle/20.500.13053/4609/>
22. Alarcón R, Ingaruca D. Satisfacción del cuidado de enfermería en CRED de las madres de niños menores de 5 años en un Centro de Salud Materno Infantil de Lima – 2021 [tesis titulación]. Lima-Perú: Universidad Cesar Vallejo; 2021. [Internet]. Disponible en: <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/70440>
 23. Reque L. Satisfacción de las madres sobre la calidad de atención de enfermería en el consultorio de Cred en Microred Contumaza [tesis maestria]. Chiclayo-Perú: Universidad Cesar Vallejo; 2020. [Internet]. Disponible en: <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/47704/>
 24. Quispe M. Satisfacción de las madres sobre la calidad de la atención que brinda las enfermeras en el consultorio de crecimiento y desarrollo del niño- puesto de salud I-2 Amandani, Puno 2018. [Tesis]. Puno: Universidad Nacional del Altiplano; 2018. [Internet]. Disponible en: <http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/8502/>
 25. Alligood M, Tomey A. Nursing models and theories. 9° Edition. United States: Elsevier; 2018.
 26. Ccahua L. Nivel de satisfacción de las madres, sobre la atención de Enfermería en madres de niños menores a 5 años, en el servicio CRED, Puesto de Salud de Huarcondo-Cusco, 2019 [tesis Bachiller]. Cuzco-Perú: Universidad Andina del Cuzco; 2019. [Internet]. Disponible en: <https://repositorio.uandina.edu.pe/handle/20.500.12557/3006>
 27. Watson J. Teoría del cuidado humano de Jean Watson. Revista de Actualizaciones en enfermería. 2013;4. [Internet]. Disponible en: <http://colombia.com/medicina/revistasmedicas/enfermería/ve104/trabajoslibres>.
 28. Donabedian, Avedis. “Evaluating the Quality of Medical Care.” The Milbank Memorial Fund Quarterly. 1966;44(3):166. Disponible en: <https://doi.org/10.2307/3348969/>.

ANEXO A: CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO ²³

Confiabilidad del cuestionario de Nivel de satisfacción de las madres sobre la calidad de atención de enfermería en el consultorio de CRED

Alfa de Cronbach	N de elementos
,942	12

Fuente: Cuestionario de Nivel de satisfacción de las madres sobre la calidad de atención de enfermería en el consultorio de Cred.

ANEXO B: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Presentación:

El presente cuestionario busca obtener información sobre la percepción de la atención de enfermería, en el programa de crecimiento y desarrollo, en las madres de niños menores de 5 años que acuden al Centro de Salud Jesús María; por lo cual solicitamos su participación para el llenado del presente cuestionario que es anónimo y las respuestas solo serán de uso para fines del estudio. Le pedimos que la respuesta sea lo más veraz y sincera.

Datos Generales de la madre:

1. Edad: _____
2. Estado civil: Soltera () Conviviente () Casada () Separada ()
3. Grado de Instrucción: Sin Instrucción () Primaria () Secundaria ()
Superior ()
4. Ocupación: _____

Datos del niño:

5. Edad: _____
6. Sexo: Masculino () Femenino ()

**SATISFACCIÓN DE LAS MADRES SOBRE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN QUE
BRINDA LA ENFERMERA EN EL SERVICIO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO
INFANTIL DEL CENTRO DE SALUD "JESÚS MARÍA" EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS
DURANTE EL 2024**

A continuación, se les presenta una serie de ítems, lea cuidadosamente cada uno. Marque con un aspa (X) en cualquiera de los 3 recuadros que usted considere conveniente.

1 = Nunca

2 = A veces

3 = Siempre

	Ítems	1	2	3
Dimensión: Humana				
1	Al ingresar al consultorio de CRED la enfermera saluda y se despide de usted amablemente.			
2	La comunicación de la enfermera es clara con usted y su niño(a).			
3	La enfermera la trata con respeto durante la consulta.			
4	Durante la atención la enfermera mantiene un tono de voz adecuado			
5	La enfermera le brinda una explicación con palabras sencillas de los procedimientos que realiza a su niño			
6	La enfermera le pregunta si usted comprendió lo explicado.			
7	La enfermera le informa la importancia de las vacunas correspondientes según el esquema de vacunación y edad de su niño.			
8	La enfermera muestra y brinda importancia a los problemas de conducta que tuviera su niño (a) como: llanto u otros.			
9	La enfermera pregunta las razones de su inasistencia a los controles de su niño(a) y/o felicita por haber acudido responsablemente al puesto de salud.			

Dimensión: Técnico-Científico				
10	La enfermera brinda la importancia a la toma de medidas de peso y talla a su niño (a).			
11	La enfermera registra el peso y talla en el <u>carpet</u> de CRED explicándole el estado nutricional de su niño (a).			
12	La enfermera realiza el lavado de manos antes y después de examinar a su niño (a).			
13	La enfermera examina a su niño (a) desde la cabeza hasta los pies.			
14	La enfermera le sonríe y le habla a su niño (a) cuando lo evalúa.			
15	La enfermera evalúa el desarrollo de su niño: el habla y el comportamiento físico.			
16	La enfermera utiliza juguetes u otros materiales cuando evalúa a su niño (a).			
17	La enfermera aclara sus preguntas o dudas sobre la crianza de su niño(a).			
18	La enfermera educa sobre los cuidados de su niño (a) en el hogar como: alimentación, accidentes, higiene, estimulación temprana, ventilación de los ambientes en el hogar, otros.			
19	Ante un problema detectado en la salud de su niño (a), la enfermera le informa y lo deriva a un especialista.			
20	El tiempo de espera para la atención de su niño(a) y el tiempo que dura la atención es adecuada.			
Dimensión: Entorno				
21	El consultorio de CRED es limpio y ordenado.			
22	El consultorio de CRED esta adecuado para que tu niño(a) se sienta cómodo(a) "colores, adornos, luz y calor"			
23	Se mantiene la privacidad durante el control de su niño(a).			
24	Las condiciones físicas del consultorio de CRED son seguras para tu niño(a).			
25	El consultorio de CRED cuenta con sus espacios respectivos, como: lavado de manos, tamizaje de anemia, otros).			

ANEXO D: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES

El propósito de este protocolo es brindar, en esta investigación, una explicación clara de la naturaleza de esta, así como del rol que tienen en ella.

La meta de este estudio es evaluar la satisfacción de las madres sobre la calidad de la atención de enfermería en el seguimiento del Crecimiento y Desarrollo infantil del Centro de Salud "Jesús María" durante el 2024.

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder a una entrevista a profundidad lo que le tomará 5 a 10 minutos de su tiempo.

Su participación será voluntaria. La información que se recoja será estrictamente confidencial y no se podrá utilizar para ningún otro propósito que no esté contemplado en esta investigación.

En principio, las entrevistas serán totalmente confidencial, no se le pedirá identificación alguna.

Si tuviera alguna duda con relación al desarrollo de la investigación, usted es libre de formular las preguntas que considere pertinentes. Además, puede finalizar su participación en cualquier momento del estudio sin que esto represente algún perjuicio para usted. Si se sintiera incómoda o incómodo, frente a alguna de las preguntas, puede ponerlo en conocimiento de la persona a cargo de la investigación y abstenerse de responder.

Muchas gracias por su participación.

Yo,.....doy mi consentimiento para participar en el estudio y soy consciente de que mi participación es enteramente voluntaria. He recibido información en forma verbal sobre el estudio mencionado. He tenido la oportunidad de discutir sobre el estudio y hacer preguntas.

Al firmar este protocolo estoy de acuerdo con que mis datos personales, incluyendo datos relacionados a mi salud física y mental o condición, y raza u origen étnico, puedan ser usados según lo descrito en la hoja de información que detalla la investigación en la que estoy participando.

Entiendo que puedo finalizar mi participación en el estudio en cualquier momento, sin que esto represente algún perjuicio para mí.

Entiendo que recibiré una copia de este formulario de consentimiento e información del estudio y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido.

Dentro de los beneficios está la contribución al desarrollo de la investigación, la cual servirá de aporte científico a la mejora continua con resultados que podrán extenderse a ámbitos nacionales.

Nombre completo del participante

Firma

Fecha

Nombre del Investigador

Firma

Fecha